

# Guía clínica: Ansiedad Social

El trastorno de ansiedad social (fobia social) implica miedo marcado a situaciones sociales o de actuación por temor al escrutinio o juicio negativo de otros.

## 1. Presentación clínica

| Situaciones frecuentemente evitadas   | Síntomas en situación social          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Hablar en público.                  | • Sonrojarse, sudoración visible.     |
| • Comer o beber frente a otros.       | • Temblor de manos o voz.             |
| • Iniciar o mantener conversaciones.  | • Taquicardia, sensación de vacío.    |
| • Situaciones de evaluación o examen. | • Mente en blanco.                    |
| • Fiestas, reuniones sociales.        | • Hipervigilancia a señales sociales. |
| • Usar baños públicos.                | • Procesamiento post-evento negativo. |

## 2. Modelo cognitivo de Clark y Wells

Situación social → Activación de supuestos disfuncionales → Percepción de amenaza social → Procesamiento autofocalizado (imagen de sí mismo desde dentro) → Síntomas visibles → Conductas de seguridad → Confirmación de la amenaza. El procesamiento post-evento mantiene el ciclo.

## 3. Factores de mantenimiento específicos

- Procesamiento autofocalizado: atención centrada en uno mismo en lugar de en la situación.
- Conductas de seguridad: hablar poco, evitar el contacto visual, preparar respuestas de antemano.
- Procesamiento post-evento: repaso negativo de la actuación social tras la situación.
- Sesgos de interpretación: sobreestimación del impacto de los errores en los demás.
- Estándares sociales muy elevados e inflexibles.

## 4. Intervención recomendada

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Psicoeducación                   | Explicar el modelo cognitivo. Identificar conductas de seguridad y su función mantenedora. |
| Atención focalizada externamente | Entrenar la atención hacia el entorno y los otros, en lugar de hacia sí mismo.             |
| Reestructuración cognitiva       | Trabajar predicciones negativas. Experimentos conductuales sin conductas de seguridad.     |

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exposición gradual</b>                     | Jerarquía de situaciones sociales. Exposición sin conductas de seguridad.                  |
| <b>Trabajo post-evento</b>                    | Revisar el repaso negativo. Introducir perspectiva más equilibrada de la actuación social. |
| <b>Habilidades sociales (si déficit real)</b> | Solo si hay déficit real: role-playing, modelado, entrenamiento asertivo.                  |

## 5. Consideraciones importantes

- Distinguir entre déficit de habilidades sociales y inhibición por ansiedad: la intervención difiere.
- Las conductas de seguridad deben eliminarse durante la exposición para que sea eficaz.
- El procesamiento post-evento puede trabajarse con un diario de evidencias contrastado.

## Notas clínicas

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Situaciones más evitadas / conductas de seguridad identificadas:</i></b> |
|                                                                                |
| <b><i>Predicciones negativas centrales del/la paciente:</i></b>                |
|                                                                                |